

monotropism-autism-prevalence-global_pl

Autyzm i monotropizm: jak naprawdę powszechne są?

Cytowany przegląd badawczy — sprawdzający regionalne dane o autyzmie i pytanie „jaki odsetek ludzi jest monotropowy”.

Informacyjne, nie porada medyczna. Te liczby opisują ilu ludzi jest liczonych jako autystyczni lub osiąga wysokie wyniki w skali monotropizmu. Liczenie zależy mocno od tego, kto szuka, jak i gdzie. Nic tu nie jest diagnostyczne.

Podsumowanie

- **Autyzm to nie 1% wszędzie.** Najczystsza globalną liczbą jest szacunek **Global Burden of Disease (GBD) 2021**, obecnie przyjęty przez WHO: około **1 na 127 osób (~0,8%)** było w spektrum autyzmu w 2021 [1][2]. Dla *dzieci* zrecenzowane przeglądy wciąż dają około **~1 na 100** od dawna [3]. Stany Zjednoczone — kraj najbardziej intensywnie badany — raportują **1 na 31 (3,2%)** wśród 8-latków (CDC, dane 2022) [4].
- **Różnice regionalne są głównie artefaktem pomiaru, nie biologią.** Ta sama studia GBD znalazła obciążenie związane z autyzmem *najniższe* w Azji Południowo-Wschodniej/Wschodniej i Oceani oraz *najwyższe* w superregionie o wysokich dochodach [1]. Ten wzorec odzwierciedla infrastrukturę diagnostyczną, świadomość i skryning — nie rzeczywiste różnice w częstości występowania autyzmu.
- **Często cytowana tabela regionalna jest istotnie błędna dla Bliskiego Wschodu i zbyt uproszczona dla Azji.** Metaanaliza z 2025

podaje połączoną prevalencję Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) tylko **~0,14%** (zakres 0,01% Oman → 2,51% Arabia Saudyjska) [6], a azjatycka metaanaliza raportuje dla Azji Wschodniej **~0,51%** i Chiny kontynentalne **~0,7%** [5][7] — daleko poniżej często twierdzonych „0,9–1,5%” dla świata arabskiego.

- **Monotropizm nie ma uzgodnionej „prewalencji”, a liczba „15–20% ludzi jest monotropowych” jest błędem kategorii.** Monotropizm jest wymiarowym stylem poznawczym (cechą ciągłą), nie diagnozą. Jedyna duża studia empiryczna — **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — znalazła, że uczestnicy autystyczni osiągnęli średnio **4,15/5** a nie-autystyczni **3,19/5**, ze znacznym nakładaniem [10]. Nie mówi **nie** „X% ludzi jest monotropowych”.
- **Twierdzenie „>90% ludzi autystycznych jest monotropowych” jest stwierdzeniem teoretycznym o tym, jak dobrze teoria ujmuje doświadczenie autystyczne, nie mierzonym odsetkiem.** Jest obronne jako *ważność subiektywna*, mylące jako *epidemiologia*.

1. Ilu ludzi jest autystycznych? (i dlaczego istnieją dwie liczby wiodące)

Dwie liczby krążą i odpowiadają na nieco inne pytania:

- **~1 na 100 dzieci.** To liczba połączona z dziesiątek studiów w przeglądach systematycznych (np. Zeidan et al., 2022) i jest od dawna *skoncentrowanym na dzieciach* podsumowaniem WHO [3]. Odbija studia, które głównie badają populacje dziecięce.
- **1 na 127 osób (~0,79%), wszystkie wieki.** To modelowy szacunek **GBD 2021** — 61,8 miliona ludzi w 2021 — który WHO przyjęło dosłownie („W 2021 około 1 na 127 osób miało autyzm”) [1][2]. Jest niższy na mieszkańca, bo obejmuje całą długość życia, włączając starsze pokolenia, które nigdy nie były badane.

Różnica między „1 na 100” a „1 na 127” nie jest sprzecznością: pierwsza to dzieci, druga to wszyscy. Obie są obronne, jeśli populacja jest określona.

GBD podaje też jasny podział na płeć — około **1,06% mężczyzn** vs **0,51% kobiet** (1.064,7 vs 508,1 na 100.000) — odzwierciedlający dobrze udokumentowane niedorozpoznanie autystycznych dziewcząt i kobiet, nie dwukrotną różnicę biologiczną [1].

2. Dlaczego liczby regionalne się różnią (różnice mierzą głównie wykrywanie, nie biologię)

To jest najważniejszy punkt przy czytaniu jakiejkolwiek tabeli regionalnej. Autorzy GBD 2021 stwierdzili, że obciążenie zdrowotne związane z autyzmem wahało się od **126,5 lat życia skorygowanych o niepełnosprawność (DALY) na 100.000** w superregionie Azja Płd-Wsch/Wsch i Oceania do **204,1 na 100.000** w superregionie o wysokich dochodach [1]. Mówiąc wprost: bogatsze, bardziej badane części świata *znajdują* znacznie więcej autyzmu niż reszta.

Sterowniki luki są niemal całkowicie metodologiczne i społeczne:

- **Infrastruktura diagnostyczna** — aktywne sieci nadzoru (np. ADDM CDC w USA) systematycznie szukają przypadków w szkołach i klinikach; wiele krajów nie ma takiego systemu i polega na pasywnych aktach klinicznych.
- **Kryteria i świadomość** — przejście od wąskiego „zaburzenia autystycznego” (DSM-IV) do szerszego spektrum autyzmu (DSM-5, 2013), plus rosnąca publiczna i fachowa świadomość, stale zwiększały *zidentyfikowaną* prevalencję w krajach ponownie badających.
- **Stygmatyzacja, język i dostęp do usług** — w wielu regionach autyzm jest niedostatecznie raportowany, bo rodziny stygmatyzują, brakuje usług, albo narzędzia skринingowe nie są walidowane w lokalnym języku i kulturze.

Więc kiedy tabela pokazuje „0,1% w regionie X i 3% w regionie Y”, czytaj to jako „*region Y szuka intensywniej i ma większą zdolność diagnozowania*” nie „*autyzm jest trzydzieści razy rzadszy w regionie X*”. Autorzy GBD podkreślają właśnie to: lepsze globalne pokrycie danymi jest potrzebne, zanim można pewnie interpretować zmienność geograficzną [1].

3. Poprawiona tabela regionalna

Liczby, które wywołały ten przegląd, są tu zestawione z najlepszą dostępną evidencją. Kolumny „najlepszy szacunek” cytują podstawowe przeglądy systematyczne lub model GBD — nie zaokrąglone zestawienia rzecznictwa.

Region	Często cytowana liczba	Co wspiera evidencja	Źródło
Świat — wszystkie wieki	„1%”	1 na 127 (~0,79%) w 2021 (GBD; obecnie liczba WHO)	[1][2]
Świat — dzieci	„1 na 100”	~1 na 100 dzieci (połączone przeglądy)	[3]
Ameryka Północna	„1–3,2%”	3,2% (1 na 31) amerykańskich 8-latków (2022, CDC ADDM); ~1 na 45 dorosłych	[4]
Europa	„0,7–1%”	Studia oparte na rejestrach skupiają się wokół ~1% (np. Dania, Finlandia, Islandia); populacyjne szacunki nieco wyższe	[3]
Bliski Wschód i Afryka Płn.	„0,9–1,5%”	Połączone ~0,14% (95% CI 0,02–0,36%); zakres krajowy 0,01% (Oman) → 2,51% (Arabia Saudyjska)	[6]
Azja Wschodnia / Płd-Wsch.	„0,4–1,4%”	Azjatycka metaanaliza: Azja Wschodnia ~0,51%, Azja Południowa ~0,31%, Azja Zachodnia ~0,35%; Chiny kontynentalne ~0,7% (1 na 143); silnie badane obszary (Singapur, Japonia, Korea Płd.) raportują wyższe	[5][7]

Dwa wnioski z tabeli:

1. Zakresy **północnoamerykańskie i europejskie** są ogólnie poprawne — to najbardziej badane regiony, więc ich wysokie liczby są oczekiwane.
2. Liczba **MENA** to duży błąd. Połączona prevalencja bliska **0,14%** niemal na pewno odzwierciedla *niedodiagnozowanie i słaby nadzór*, nie genuinely rzadszy autyzm. Ogromne rozstrzał wewnątrz-regionu (Oman 0,01% do Arabia Saudyjska 2,51%) jest sam w sobie znakiem:

prawdziwa biologia nie różni się tak bardzo między sąsiednimi krajami; nadzór już tak [6].

4. Czy autyzm naprawdę „rośnie”?

Prevalencja nagłówkowa silnie wzrosła — w USA z około 1 na 150 (2000) do 1 na 31 (2022) [4]. Dominujące wyjaśnienie epidemiologów to **lepsz a i szersza identyfikacja**, niekoniecznie więcej autyzmu:

- poszerzone kryteria (DSM-IV → DSM-5),
- aktywne szukanie przypadków (nadzór typu ADDM),
- wcześniejszy i bardziej sprawiedliwy skrining wg płci, rasy i pochodzenia etnicznego,
- zmniejszona stygmatyzacja prowadząca do więcej ocen.

Autorzy GBD notują, że prevalencja była porównywczo *stabilna* tam, gdzie kontroluje się jakość danych, i że pozorne „wzrosty” głównie idą za zdolnością wykrywania [1]. Uczciwe podsumowanie: **coraz bardziej liczymy autyzm, który zawsze tam był**.

5. Ilu ludzi jest „monotropowych”? (pytanie bez jednej odpowiedzi)

Monotropizm (Murray, Lawson & Lesser, 2005) to *oparty na uwadze* opis autyzmu: umysł monotropowy koncentruje zasoby w kilku intensywnie aktywnych „tunelach uwagi”, zamiast rozkładać uwagę na wiele kanałów (polytropizm). Co kluczowe, jest ujęty jako **różnica w alokacji uwagi, nie deficyt** — i jako **spektrum**, nie kategoria tak/nie.

Dlatego nie ma **uzgodnionej prevalencji „monotropizmu”**, z trzech powodów strukturalnych:

1. **Nie jest diagnozą.** Monotropizm nie występuje ani w DSM-5, ani w ICD-11. Nie ma rejestru przypadków ani prognozy diagnostycznej.
2. **Jest wymiarowy, nie kategoryjny.** Każdy może wejść w skoncentrowany stan „flow”; różnica autystyczna polega na tym, że głęboki, wąski fokus jest *domyślnym trybem operacyjnym* raczej niż stanem okazjonalnym. Linia między „monotropowym” a „polytropowym” byłaby arbitralna.
3. **Narzędzie raportuje średnie, nie przypadki.** Zwalidowane narzędzie — **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 —

daje ciągły wynik od 1 do 5, a badacze porównują *średnie grupowe*, nie „ilu ludzi przekracza punkt odcięcia” [10].

Rzeczywiste liczby, które mamy (studia walidacyjne MQ)

W studium rozwoju MQ (1.110 uczestników: 756 autystycznych, 354 nie-autystycznych) [10]:

- **Uczestnicy autystyczni: średnia 4,15 / 5 (OD 0,347)**
- **Uczestnicy nie-autystyczni: średnia 3,19 / 5 (OD 0,578)**
- **Status ADHD** niezależnie przewidywał wyższe wyniki monotropizmu (istotne, bo autyzm i ADHD współwystępują w około 30–80% przypadków w zależności od kierunku).
- Eksploracyjna analiza czynnikowa dała **strukturę 8-czynnikową** (specjalne zainteresowania; ruminacja/lęk; potrzeba rutyn; środowisko i tunel uwagi; gubienie otoczenia; podejmowanie decyzji; efekt lękowstrzymujący zainteresowań; zarządzanie interakcjami społecznymi).

Nakładanie się dwóch rozkładów jest znaczne — wielu nie-autystycznych ludzi ma wyniki powyżej niektórych autystycznych i odwrotnie. To nakładanie to *dokładnie* dlaczego nagłówek „X% populacji jest monotropowa” nie jest sensowny bez arbitralnego (i spornego) punktu odcięcia.

6. Skąd liczby „>90%” i „15–20%” — i dlaczego nie są danymi prevalencji

Te dwie liczby, szeroko krążące w sieci, zasługują na bezpośrednie sprawdzenie.

„>90% ludzi autystycznych jest monotropowych.” To najlepiej czytać jako twierdzenie o **ważności subiektywnej** — to znaczy: *kiedy ludzie autystyczni spotykają się z ramą monotropizmu, przytłaczająca większość rozpoznaje ją jako dokładny opis swojego doświadczenia*. To jest realne i znaczące zjawisko (MQ był zbudowany z grupą społeczności kierowaną przez autystów właśnie dlatego, że opis rezonował [10]). Ale **to nie jest epidemiologiczna prevalencja**; żadne studium nie obliczyło „odsetka ludzi autystycznych, którzy są monotropowi” względem zwalidowanego progu, bo nie ma uzgodnionego progu. Sformułowane jako

„monotropizm ma bardzo wysoką wagę subiektywną dla ludzi autystycznych”, jest obronne; sformułowane jako „ponad 90% ludzi autystycznych jest monotropowych”, przecenia to, co zmierzono.

„**15–20% populacji ogólnej jest monotropowych.**” Ta liczba jest prawie na pewno **pomieszaniem z „neurodywergencją”**. Szacunki społeczności sytuują *jakąś* formę neurodywergencji (ADHD, dysleksja, dyspraksja, Tourette, itp., z silnym nakładaniem) rzędu 15–20% populacji. Dla kontekstu, nawet lepiej mierzone komponenty są znacznie mniejsze w izolacji: dorosłe ADHD dotyka około **2,58%** (persistentne) do **6,76%** (symptomatyczne) dorosłych globalnie [8], a dziecięce ADHD jest często szacowane wokół 5–8%. Dysleksja jest często cytowana blisko ~10% w zależności od definicji. **Żadna z tych nie jest liczbą monotropizmu.** Równanie „neurodywergencyjny” z „monotropowy” jest błędem kategorii: monotropizm jest jednym *wymiarem* stylu poznawczego, który jest podwyższony w — ale nie identyczny z — kilkoma profilami neurodywergencyjnymi. Obecnie **nie ma liczby opartej na evidencji** dla prevalencji monotropizmu w populacji ogólnej.

***Konkluzja o monotropizmie:** traktuj go jako mierzalną tendencję na spektrum, silnie (ale nie wyłącznie) związaną z autyzmem i ADHD, o wysokiej wadze z doświadczenia dla ludzi autystycznych. Uczciwa odpowiedź na „jaki odsetek ludzi jest monotropowy?” brzmi: to nie jest jeszcze dobrze zdefiniowane pytanie, a każdy precyzyjny odsetek, który widzisz, jest wymyślony.*

7. Praktyczne wnioski

- **Cytuj liczbę pasującą do populacji.** „1 na 127 osób” (wszystkie wieki, GBD/WHO) i „~1 na 100 dzieci” to oba poprawne — nazwij, którą masz na myśli [1][2][3].
- **Traktuj regionalne luki jako luki w wykrywaniu.** Nisko raportowana prevalencja w MENA, części Azji oraz u dziewcząt/kobiet, starszych dorosłych i grup rasjalizowanych odzwierciedla niedoidentyfikowanie, nie brak [1][6].
- **Nie przedstawiaj monotropizmu jako mającego prevalencję.** Raportuj średnie MQ i ramy wymiarowe; unikaj „>90%” i „15–20%” jako twierdzeń prevalencji [10].

- **Utrzymuj ramy neuroafirmujące.** Wyższa *identyfikacja* autyzmu w dobrze zaopatrzonych krajach to sukces świadomości i dostępu; monotropowy vs polytropowy to *różnica uwagi*, nie deficyt — spójne z tym, jak twórcy i społeczność autystyczna ramują teorię.
-

Źródła

- [1] Global Burden of Disease Study 2021 Autism Spectrum Collaborators (2024). *The global epidemiology and health burden of the autism spectrum: findings from the Global Burden of Disease Study 2021*. The Lancet Psychiatry (19 Dec 2024). doi:10.1016/S2215-0366(24)00363-8 — 61,8 mln ludzi (1 na 127) w 2021; prevalencja standaryzowana wiekowo 788,3/100.000 (mężczyźni 1.064,7; kobiety 508,1); super-regionalne DALY 126,5 (SE/E Azja i Oceania) do 204,1 (wysokie dochody) na 100.000. [https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(24\)00363-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(24)00363-8/fulltext) · IHME: <https://www.healthdata.org/research-analysis/library/global-epidemiology-and-health-burden-autism-spectrum-findings-global>
- [2] World Health Organization (2024). *Autism fact sheet (key facts)*. — „In 2021 about 1 in 127 persons had autism.” <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- [3] Zeidan, J. et al. (2022). *Global prevalence of autism: A systematic review update*. Autism Research (Wiley). doi:10.1002/aur.2696 — ~1 na 100 dzieci; europejskie dane rejestrowe (Francja, Dania, Finlandia, Islandia). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2696>
- [4] CDC, Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network (2025). *Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — ADDM Network, 16 sites, United States, 2022*. MMWR, 74(SS-2). — 1 na 31 (3,2%) wśród 8-latków. Raport społeczności: <https://www.cdc.gov/autism/media/pdfs/2025/04/ADDM-Community-Report-SY2022.pdf> · MMWR: <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/ss/ss7402a1.htm>
- [5] Lu, Y. et al. (2020). *Prevalence of autism spectrum disorder in Asia: a systematic review and meta-analysis*. Psychiatry Research, 284, 112679. doi:10.1016/j.psychres.2019.112679 (PMID 31735373) — Azja Wschodnia

0,51%, Azja Południowa 0,31%, Azja Zachodnia 0,35%.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31735373>

[6] Abdallah, B.M. et al. (2025). *Estimates of the prevalence of autism spectrum disorder in the Middle East and North Africa region: a systematic review and meta-analysis*. BMC Public Health, 25:2519. doi:10.1186/s12889-025-23651-x (PMID 40691829) — połączone 0,14% (95% CI 0,02–0,36%); zakres krajowy 0,01% (Oman) do 2,51% (Arabia Saudyjska). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40691829>

[7] Jiang, X. et al. (2024). *Prevalence of autism spectrum disorder in mainland China over the past 6 years: a systematic review and meta-analysis*. BMC Psychiatry (PMID 38811881) — ~0,7% od 2017 (~1 na 143). Potwierdzone przez policyjny przegląd (SAGE) 2024. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38811881>

[8] Song, P. et al. (2021). *The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a global systematic review and meta-analysis*. General Psychiatry / PMC7916320 — persistente dorosłe ADHD 2,58%; symptomatyczne 6,76%. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7916320>

[9] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156. doi:10.1177/1362361305051398 — początek teorii monotropizmu. <https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

[10] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (47-item self-report measure; validation preprint). Open Science Framework. — n = 1.110 (756 autystycznych, 354 nie-autystycznych); średnia autystycznych 4,15 (OD 0,347) vs nie-autystycznych 3,19 (OD 0,578) na skali 1–5; ADHD niezależnie przewidywało wyższe wyniki; struktura 8-czynnikowa. Plik kwestionariusza: <https://osf.io/wpx5g> · preprint walidacyjny: <https://osf.io/ft73y> · licencja: CC BY-NC-SA 4.0. Lokalne archiwum: <sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf>